

Sotsiaalselt investeeriv riik. Kuidas ja miks peaks omastehooldusesse investeerima?



Häli Tarum

sotsioloogia eriala doktorant, Tartu Ülikool

Eesti sotsiaalpoliitikat reguleerivatesse arengukavadesse on hakanud puhuma uued tuuled. „Heaolu arengukava 2016–2023”, mis koondab endas tööhõive, sotsiaalkaitse ja võrdse kohtlemise poliitikate strateegilised eesmärgid, lähtub Euroopa Liidu (EL) sotsiaalpoliitika mudelist, mille keskmes on ettekujutus sotsiaalselt investeerivast riigist.

Sotsiaalselt investeeriv riik on mujal maailmas sotsiaalpoliitilises arutelus ja teaduskirjanduses palju käsitletud teema, mistõttu on oluline selle põhimõtteid ka Eestis laiemale auditooriumile tutvustada, et selgitada, mis selle kontseptsiooni rakendamine Eesti sotsiaalpoliitikas ja seda ellu viivas sotsiaaltöös endaga kaasa võib tuua. Selle kõrval on käesolevas artiklis tähelepanu all eakate inimeste mitteformaalsed hooldajad, sealhulgas omastehooldajad¹, kelle olukorda arengukavas ette nähtud muudatused ka puudutavad. Seega on artikli eesmärk tutvustada sotsiaalselt investeeriva riigi kontseptsiooni ning vaadata, mis selle rakendamine arengukava valguses mitteformaalsete hooldajate positsioonile tähendada võib.

Mida tähendab sotsiaalselt investeeriv riik?

Sotsiaalselt investeeriva riigi idee pärineb Rootsist, kus 1930. aastatel otsiti vastust küsimusele, kuidas lahendada väheneva rahvastiku probleem ning muuta laste saamine peredele atraktiivsemaks. Selleks käisid Nobeli preemia laureaadid, abielupaar Alva ja Gunnar Myrdal (1934) välja idee, et sotsiaalpoliitikat peaks senisest korraldama efektiivsemalt ning sotsiaalvaldkonna kulutusi ei tohiks käsitleda kui lihtsalt kuluallikaid, vaid neid peaks nägema kui investeeringuid, mis pikas perspektiivis ennast ära tasuvad. Sellest hetkest alates on sotsiaalselt investeeriva riigi kontseptsioon erinevates käsitlustes

¹ Rahvusvahelises teaduskirjanduses eristatakse mitteformaalset hooldajat (ingl *informal carer*) ja omastehooldajat (ingl *family carer*). Mitteformaalsete hooldajate hulka kuuluvad ka omastehooldajad ehk hooldatava sugulased ning pereliikmed, kuid mitteformaalseteks hooldajateks võivad olla ka hooldatava sõbrad, tuttavad jt. Seega on mitteformaalse hooldaja mõiste omastehooldaja mõistest laiem.

täiustunud ning sotsiaalselt investeeriva riigi ideest lähtuvaid poliitikaid on ellu viidud mitmetes riikides. Kuigi sotsiaalselt investeeriva riigi kontseptsioon on ELis kasutusel olnud juba kauemat aega, siis jäädavalt kinnistus see 2013. aastal Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud „Sotsiaalsete investeeringute pakettis” (European Commission 2013), milles nähti ette abinõud võitlemaks majanduskriisi tagajärjel suurenenud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega. Seega on sotsiaalne investeerimine midagi, mida tuleb ellu viia terves ELis, sealhulgas ka Eestis.

Sotsiaalselt investeeriva riigi peamine idee on sotsiaal- ja majanduspoliitika eesmärkide omavaheline ühitamine: sotsiaalpoliitika kaudu toetatakse riigi arengut ehk investeeringud sotsiaalvaldkonda peaksid tooma riigile ka majanduslikku kasu (Perkins jt 2004). Kontseptsiooni kolm peamist põhimõtet on järgmised:

- 1) sotsiaalse kaasatuse saavutamine töö kaudu: inimene on ühiskonnaelu osaline siis, kui ta käib tööl
- 2) rõhuasetus üksikisiku vastutusele: riik on loonud inimestele võimaluse arenguks ja tööturul osalemiseks, kuid inimene ise on isiklikult vastutav oma heaolu eest
- 3) investeerimine inimkapitali ehk inimeste oskustesse ja teadmistesse, mis kindlustaks neile võimalikult hea positsiooni tööturul (Cantillon ja Van Lancker 2013).

Seega on sotsiaalse investeerimise strateegia keskmes soov luua kõigile inimestele ligipääs ja võimalused tööturul osalemiseks. Iga sotsiaalpoliitilise meetme rakendamisel peaks mõtlema, kuidas selle kaudu soodustada inimeste osalemist tööturul. Kuidas on see kõik aga seotud mitteformaalsete hooldajatega ning mil määral annab sotsiaalselt investeeriva riigi kontseptsiooni rakendada nende puhul?

Mitteformaalsed hooldajad Eestis ja mujal

Kaasaegsetes riikides on vastutus eakate hooldamise eest jagatud riigi ja perekonna vahel. Lisaks võivad eakatele hoolekannet pakkuda nii erinevad ettevõtted, MTÜd kui ka eaka sõbrad ja tuttavad. Üheski riigis ei ole eakate hoolekanne tagatud täies mahus formaalsete teenustega nii, et perekonnaliikmed üldse ei peaks omaste eest hoolt kandma. OECD aruande (2005) kohaselt on arenenud riikides ligi 80% kõigist hooldusvajadusega eakatest hooldatud mitteformaalsete hooldajate poolt. Eestis hooldasid hooldust vajavaid eakaid 2007. aastal 85% juhtudel mitteformaalsed hooldajad ning 15% hooldusvajadusest rahuldati formaalsete teenuste kaudu (PriceWaterhouseCoopers 2009). Seega pole Eesti numbrid mitteformaalse hoolduse leviku osas arenenud riikidega võrreldes midagi silmatorkavat. Omastehooldus on eksisteerinud aegade algusest ning kindlasti on sellel oluline roll ka tulevikus. Vananeva rahvastiku tõttu kasvab nii Eestis kui mujal Euroopas hooldust vajavate eakate arv, mis omakorda viib selleni, et mitteformaalseid hooldajaid on tulevikus rohkem.

Samas peaks sotsiaalselt investeeriva riigi kontseptsiooni kohaselt riik pürgima võimalikult kõrge tööhõive poole ehk toetama erinevate sotsiaalsete gruppide, sealhulgas mitteformaalsete hooldajate, tööl käimist. Teaduskirjandusest on aga teiste riikide näitel teada, et intensiivne hoolduskoormus võib segada hooldajate tööl käimist (Carmichael ja Charles 1998), vähendada töötatud tundide arvu (Johnson ja Lo Sasso 2000) ja sissetulekut (Heitmueller ja Inglis 2007). Samuti on selgunud (Arksey jt 2005), et raskused töö ja hooldamise ühitamisel võivad viia selleni, et mitteformaalsed hooldajad jäävad varakult pensionile, sest intensiivne hoolduskoormus takistab neil tööl käimist.

Seetõttu peaks sotsiaalse investeerimise kontseptsioonist lähtuv riik eakate hoolekandesse ja mitteformaalsesse hooldusesse investeerima nii, et see aitaks kaasa hooldajate tööturul osalemisele.

Kui seni on Eestis enam tähelepanu pälvinud lapsevanemate töö ja pereelu ühitamise toetamine nii vanemahüvitise kui lasteaiakohtade loomise kaudu, siis sotsiaalse investeerimise kontseptsiooni järgi tuleks samamoodi toetada mitteformaalsete hooldajate töö ja hooldamise ühitamist. Kokkuvõttes võib see olla riigi jaoks n-ö odavam ja majanduslikult otstarbekam, kui hooldajad käivad tööl, panustavad hõivesse, neilt laekub maksutulu ning riik suunab senisest enam ressursse eakate hoolekandesse.

See ei tähenda, et riik peaks kõigil juhtudel eakate hoolekande täielikult enda kanda võtma, pigem on oluline vähendada perekondade hoolduskoormust nii, et hooldajatel oleks lihtsam käia tööl ja pakkuda oma lähedastele samal ajal kvaliteetsemat hooldust. Teiste riikide praktikast (Brandt 2013) on teada, et kui riigi poolt toetatud formaalsed eakate hoolekande teenused on kättesaadavad, siis on ka pereliikmete osutatud eakate hooldus episoodilisem ja vähem aega nõudev. Seal, kus sotsiaalteenused ei ole nii levinud, on eakate hoolekanne perekonnaliikmete jaoks ajakulukam ja intensiivsem. Seega, ei tohiks loota ega karta, et juhul kui eakate hoolekandeteenused on kättesaadavamad, võtab riik perekonna kohustused täies ulatuses enda kanda.

Näiteks Põhjamaades, kus formaalne eakate hoolekanne on perekondadele kättesaadav, hoolitsevad pereliikmed omaste eest ikka, kuid teevad seda vabatahtlikult ja mitte nii intensiivselt, samas kui Kesk- ja Lõuna-Euroopas on omastehooldus pigem sunnitud situatsioon, mis tuleneb vähestest valikuvõimalustest (Brandt 2013).

Kuidas nähakse eakate mitteformaalseid hooldajaid uues arengukavas?

Viidatud teadmiste valguses ongi oluline vaadata, kuidas „Heaolu arengukava 2016–2023” käsitleb mitteformaalseid eakate hooldajaid ning kuidas kavandatavad tegevused neid puudutavad. Arengukava annab aluse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) struktuuritoetuste kasutamiseks perioodil 2014–2020 ehk planeeritud tegevused on seotud sellega, mida neil aastatel ESFi raames Eestis tehakse. Kuna arengukava kohaselt on planeerimisel lähtutud sotsiaal- ja heaoluriigi põhimõtetest, mispuhul sotsiaal- ja tööturupoliitikat käsitletakse investeeringuna, siis vaatame, kuidas neid põhimõtteid eakate hoolekandes rakendatakse.

Arengukavas käsitletakse hoolduskoormusega inimesi riskirühmana ning tõdetakse, et: „Selline hoolduskohustus, eriti kui tegemist on pideva kõrvalabi või pikaajalise hooldusvajadusega, ei pruugi olla aga jõukohane ning võib takistada ja piirata töötamist. See omakorda kätkeb riske lähedastest hooldajate tervisele ning majanduslikule toimetulekule.”

Eakate hoolekannet puudutab kõige enam alaeasmärk: „Inimeste võimalused iseseisvalt toime tulla, kogukonnas elada ning ühiskonnaelus osaleda on tänu efektiivsele õiguskaitsele ja kvaliteetsele kõrvalabile paranenud.” Selline olukord kavatakse saavutada kolme poliitikainstrumendi abil.

Esiteks soovitakse pakkuda iseseisvat toimetulekut toetavaid kvaliteetseid sotsiaalteenuseid ja vajadustele vastavaid hooldusvõimalusi. Teisisõnu lubatakse ESFi raames nii arendada kui ka pakkuda olemasolevaid ja uusi (näiteks telehooldus) hoolekandeteenuseid ja tõsta teenuste kvaliteeti. Samas on arengukavas järgnevateks aastateks ette nähtud ka palju uusi algatusi ja plaane, mida ESFi kaudu ei finantseerita. Nii kavatakse 2018. aastal rakendada uus rehabilitatsiooni- ja

taastusraviteenuste süsteem, mille abil parandada praegu eri valdkondade poolt pakutavate rehabilitatsiooniteenuste koostimet. Samuti soovitakse olemasolevad sotsiaal-, töö- ja tervishoiuteenused panna omavahel paremini toimima. Kõige märkimisväärsimateks plaanideks võib aga pidada esiteks sotsiaalteenuste jätkusuutliku rahastamissüsteemi väljatöötamist, mille raames kavatakse üle vaadata inimeste, KOVide ning riigi osaluse põhimõtted sotsiaalteenuste eest tasumisel. Teiseks oluliseks tegevuseks on hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma kokkukutsumine, mille ülesanne on välja töötada ettepanekud hooldajate hoolduskoormuse ennetamiseks ja vähendamiseks, hooldajate tööhoive toetamiseks ning nende sotsiaalsete garantiide tagamiseks.

Teiseks arengukava poliitikainstrumendiks on erihoolekandeteenuste deinstitutionaliseerimine, mille tulemusel peaksid kliendid saama senisest enam teenuseid, mis toetavad koduses keskkonnas ja kogukonnas elamise võimalusi. Kolmanda poliitikainstrumendi raames luuakse puudega inimeste õiguste kaitse järelevalvesüsteem ning parandatakse ligipääsetavust, sh kohandatakse 2000 erivajadusega inimese eluruumid vajadustele vastavaks.

Kuigi ESFi kaudu jätkatakse eksisteeriva eakate hoolekande mudeli alusel olemasolevate ja uute teenuste pakkumist, siis võttes arvesse teenuste mahtu, ei taju neid muutusi tõenäoliselt kõik eakad ja nende omaksed. Küll aga on arengukavas ette nähtud mitmeid vajalikke muudatusi eakate hoolekandes. Kuna tegemist on alles plaanidega, siis ei saa hetkel hinnata, kas nende tegevuste tulemusel eakate hoolduses ja omastehooldajate olukorras sisuliselt midagi muutub. Kuid soov süsteem efektiivsemaks ja jätkusuutlikumaks muuta on igati asjakohane ja sellega antakse riigi tasandil märku, et soovitakse senisest

enam toetada eakate iseseivat toimetulekut ja hooldajate töö käimist, mis on igati kooskõlas sotsiaalselt investeeriva riigi põhimõtetega.

Miks peaks hooldajad üldse töölt ära tulema?

Arengukavas pööratakse mitteformaalsetele hooldajatele tähelepanu hoolekande valdkonna plaanide juures, kuid unustada ei tohiks, et sotsiaalselt investeeriva riigi kontseptsiooni üheks alustalaks on just erinevate poliitikavaldkondade, sealhulgas hoolekande- ja tööturupoliitikate senisest tihedam lõimimine. Tööturgu käsitlevas peatükis küll korraks mainitakse mitteformaalseid hooldajaid, kuid eraldi tegevusi neile töövaldkonna poliitikate all ette ei nähta.

Tõesti, ühelt poolt saab riik hooldamise ja töötamise ühitamist soodustada formaalsete eakate hoolekandeteenuste kättesaadavaks tegemisega, mis võimaldab mingi osa mitteformaalsest hooldusest üle anda, kuid teiselt poolt on võimalik ka töösuhte reguleerimisel hoolduskoormusega arvestada. Oma magistritöös (Tarum 2013) jõudsin aga järeldusele, et töötamist reguleerivates õigusaktides ei nähta hoolduskohustust kui tegurit, mis võib segada hooldaja võimalusi tööl käia. Töölepinguseaduse seletuskirjas küll väidetakse, et hoolduskohustuse tõttu ei tohi inimesi töölt lahti lasta, kuid see on ka kõik. Mingisuguseid erisusi seadused mitteformaalsetele hooldajatele ette ei näe, ja nii puuduvad need ka riiklikes õigusaktides. Mitteformaalsete hooldajate töösuhte paindlikumaks muutmine võiks aga kaasa aidata hooldajate töö käimise ja hooldamise paremale ühitamisele.

Nii näiteks võimaldatakse Saksamaal, kus eakate hoolekanne on finantseeritud pikaajalise hoolduse kindlustussüsteemi kaudu, kõigile töötajatele aastas kuni 10 päevalist ajutist hoolduspuhkust juhul, kui neil on

vajadus omaste eest hoolitseda. Töötajatel, kes töötavad vähemalt 15 töötajaga ettevõttes, on võimalus jääda kuueks kuuks osalisele või täielikule hoolduspuhkusele nii, et nende töökoht sellel perioodil säilib ja sissetulek tagatakse kindlustuse kaudu. Samuti on mitteformaalsetel hooldajatel õigus kuni kaheks aastaks vähendada oma tööaega kuni 15 tunni võrra nädalas.

Kas sotsiaalne investeerimine on alati lahendus?

Töösuhte reguleerimisel hoolduskoormusega arvestamine, nii nagu seda tehakse Saksamaal, oleks igati kooskõlas sotsiaalselt investeeriva riigi kontseptsiooniga, kuid viimastel aastatel on seda lähenemist mitmed teadlased (näiteks Cantillon ja van Lancker 2013; Morel, Palier ja Palme 2013) ka kritiseerinud. Kuigi sotsiaalselt investeeriva riigi kontseptsioon on üks Euroopa sotsiaalse mudeli aluseid, ei pruugi see olla ainuvõimalik lahendus. Kriitikute üheks peamiseks argumendiks on, et sotsiaalselt investeeriva riigi idee põhi-eeldus – sotsiaalne kaasatus läbi tööturu ehk inimeste isiklik vastutus tagada oma heaolu töötamise kaudu – ei ole kõigil juhtudel võimalik. Tüüpiline näide on raske puudega lapsed, kes tõenäoliselt omal käel kunagi tööl käima ei hakka (Cantillon ja van Lancker 2013). Nii on tööturult eemal nii puuetega lapsed ja täiskasvanud kui ka nende lähedased.

Seetõttu tuleks enne sotsiaalselt investeeriva riigi kontseptsiooni rakendamist hinnata, millised on erinevate sotsiaalsete rühmade võimalused üldse tööturul osaleda, sest kõigil juhtudel ei saa eeldada, et inimesed on kohustatud tagama oma heaolu töötamise

kaudu. Seetõttu hoiatavadki Cantillon ja van Lancker (2013), et sotsiaalselt investeeriva riigi kontseptsiooni rakendamisel ei tohi ära unustada, et vanad sotsiaalsed riskid on endiselt olemas ning kõiki kulutusi ei saa käsitleda kui sotsiaalseid investeeringuid. Klassikaline sotsiaalkaitse on samuti osa heaoluriigist ehk riigi abi ja toetus nendele sotsiaalsetele rühmadele, kes tööturul osaleda ei saa, on vajalik täiendus aktiviseerimispoliitikatele (Morel, Palier ja Palme 2013).

Niisiis võiks küsida, kas eakate mitteformaalsed hooldajad peaksid üldse tööl käima? Rakendades sotsiaalselt investeeriva riigi kontseptsiooni, oleks vastuseks „jah”. Teisalt võiks küsida, kuivõrd realistlik on see, et omastehooldajad hooldussuhte kõrvalt veel tööl käivad? Kuivõrd saab riik neid selleks kohustada? Kui vastus on, et „ei saa”, siis tuleks selle probleemiga tegeleda väljaspool sotsiaalselt investeeriva riigi raamistikku. Äkki peaks omastehooldus olema hoopis tegevus, mis on võrdsustatud töötamisega ning mille eest saab elamisväärselt palka?

Kokkuvõttes: sotsiaalselt investeeriva riigi idee rakendamine eakate hoolekandes on üks võimalik lahendus, kuid kindlasti on ka teisi arengutsenaariume, mis vajaksid kaalumist. Arengukavast nähtub, et järgnevatel aastatel plaanitakse eakate hoolekande korraldus ja mitteformaalsete hooldajate olukord võtta lähema vaatluse alla, mis on igati tervitatav. Niisiis on ootused kokkukutsutava rakkerühma suhtes suured. Vähemalt on mitteformaalsed eakate hooldajad, tõenäoliselt paljuskki ka tänu valjemale häälele ühiskonnas, pälvinud riigi tähelepanu. Nüüd jääb üle oodata lahendusi. **S**

Viidatud allikad

Arksey, H., Kemp, P., Glendinning, C., Kotchetkova, I., Tozer, R. (2005). Carers' aspirations and decisions around work and retirement (Research Report No 290). Department for Work and Pensions. www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/pdf/rrep290.pdf. (17.05.2016).